

Fecha Última Actualización: 18-06-2022 3:13:14

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Juan Manuel Serrano Serrano
Edad : 77a 8m 4d
Dirección : Finlandia 0555 Villa El Porvenir

Rut : 5.393.757-8
Fecha Nacto: 14/10/1944
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0414465
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 9450 0020

N° Epicrisis
302934

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim (5to Piso Mater)

Fecha Ingreso : 05/04/2022 20:54

Días Estadía : 74

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 18/06/2022 03:06

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Diarrea y compromiso de conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI CASR: 05/04/22
FI UTIM: 06/04/22
FI SALA: 13/04/22
FI UTIM: 25/04/22
F. TRASLADO UCI: 26/04/22

DIAGNÓSTICO INGRESO UPC

1) SHOCK SÉPTICO FOCO EN ESTUDIO (OBS. RESPIRATORIO) - IMIPENEM + LINEZOLID (FI:25/04 - DÍA 1)

·HC (25/04): PENDIENTE

·UC (25/04): OC: INFLAMATORIA, UC: PENDIENTE

2) SD. DIARREICO AGUDO X CD RESUELTO

3) INSUFICIENCIA RESPIRATORIA - EPOC EXACERBADO

·VMI DESDE 26/04

4) FA CON RVR - BIC AMIODARONA

5) OBS. PUSTULOSIS EXANTEMÁTICA GENERALIZADA AGUDA (PEGA) SOSPECHA 2RIA A FÁRMACOS, CON SOBRE INFECCIÓN MICÓTICA - FLUCONAZOL VO

6) EOSINOFILIA - SOSPECHA SECUNDARIA A FÁRMACOS (VANCOMICINA VS PIPERACILINA-TAZOBACTAM).

ANTECEDENTES

1) MÓRBIDOS: HTA, EPOC, DM2NIR, FA SIN TACO NI TTO, DLP

2) QUIRÚRGICOS: PROSTATECTOMÍA (HACE 10 A), COLE LAP (30/03/22)

3) FÁRMACOS: ATV 20 MG C/6H, LOSARTAN 50 MG C/6H, FUROSEMIDA 40 MG C/6H, METFORMINA 850 MG C/12H, BREXOTIDE 1 PUFF C/6H, SALBUTAMOL 1 PUFF C/6H, B. IPRATROPIO 3 PUFF C/8H.

4) ALERGIAS: (-)

5) HÁBITOS: TBQ (-), OH (-), DROGAS (-). EXPOSICIÓN A BIOMASA (+)

6) INMUNIZACIONES: 3 DOSIS COVID + INFLUENZA (2022)

8) SOCIAL: VIVE SÓLO EL QUISCO. DOMICILIO FONASA EN PUENTE ALTO.

HISTORIA ACTUAL

Fecha Epicrisis : 18/06/2022 03:13

Página 1 de 4

ANTECEDENTES DE HOSPITALIZACIÓN RECIENTE POR COLE LAP ELECTIVA (30/03/22), SIN INCIDENTES. CONSULTA EN SU EL 05/04 POR CUADRO DE 5 DÍAS DE DIARREA SIN ELEMENTOS PATOLÓGICOS, ASOCIADO A COMPROMISO DEL ESTADO GENERAL Y AUMENTO DE LA DISNEA BASAL, TOS Y CAMBIO EN EL ESPUTO. SIN FIEBRE, NÁUSEAS, VÓMITOS NI DOLOR ABDOMINAL. SIN CONTACTOS COVID. INGRESA AL SU FEBRIL 38.9°C, TAQUICÁRDICO 133-140 (EKG: FA CON RVR), NORMOTENSO, SIN REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO. AL EXAMEN FÍSICO, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. PACIENTE EVOLUCIONA HIPOTENSO EN SU, POR LO QUE SE INDICA VOLEMIZACIÓN CON 1 L SF 0.9% Y CEFTRIAXONA 2GR EV CON BUENA RESPUESTA. AL LABORATORIO DESTACABA GB: 15.100, PCR 27, LÁCTICO 25 QUE BARRE A 17 CON VOLEMIZACIÓN, HIPOKALEMIA LEVE 3.36, SIN DISFUNCIÓN RENAL Y OC: INFLAMARIA. SE COMPLEMENTÓ ESTUDIO CON ANGIOTAC TAP (05/04) SIN TEP, DONDE DESTACAN SIGNOS DE PROCTITIS Y SIGMOIDITIS DE PROBABLE ORIGEN INFECCIOSO. EN CONTEXTO DE SOSPECHA DE SEPSIS DE FOCO ABDOMINAL Y COBERTURA DE GÉRMENES RESISTENTES SE INICIÓ TAZONAM Y SE SOLICITÓ TOXINAS A/B DE CD (+) (06/04).

EVALUADO POR EQUIPO DE CIRUGÍA QUE DESCARTA INDICACIÓN QUIRÚRGICA. PACIENTE EVOLUCIONA EN URGENCIAS CON MALA MECÁNICA VENTILATORIA Y SIBILANCIAS DIFUSAS, MANEJADA CON BRONCODILATACIÓN, HIDROCORTISONA EV Y SULFATO DE MG CON LO QUE MEJORA MECÁNICA PERO PERSISTE SIBILANTE, POR LO QUE SE PRESENTA A MED INTERNA (UTIM) PARA CONTINUAR MANEJO

ES EVALUADO EN SALA POR EQUIPO DE DERMATOLOGÍA EL 14/04/22 POR EOSINOFILIA Y ERITEMA GLÚTEO, QUE NO IMPRESIONÓ DRESS POR FALTA DE CRITERIOS Y LESIÓN NO TÍPICA. SE INTERPRETÓ COMO CELULITIS Y SE INICIÓ TRATAMIENTO ATB CON VANCOMICINA 1G CADA 12 HORAS EV + CEFAZOLINA 2 G CADA 8 HORAS EV. REEVALUADO POR DERMATOLOGÍA EL 18/04/22 QUE AGREGAN TERBINAFINA POR SOSPECHA DE SOBREINFECCIÓN MICÓTICA, MANTENIÉNDOSE TTO ATB CON CEFAZOLINA HASTA EL 18/04/22 (DÍA 4) POR EOSINOFILIA Y VANCOMICINA EV HASTA EL 19/02/22 (DÍA 5), YA QUE PRESENTÓ PEAK FEBRIL DE 39.4, POR LO QUE SE ESCALÓ TTO A IMIPENEM. ES EVALUADO POR INFECTOLOGÍA EL 20/04 QUIENES EN RELACIÓN A FOCO CUTÁNEO SUGIEREN REINICIAR TRATAMIENTO ATB CON VANCOMICINA EV Y MANTENER TERBINAFINA TÓPICA (SUSPENDIENDO IMIPENEM) Y EN RELACIÓN AL FOCO DIGESTIVO MANTENER TRATAMIENTO CON VANCOMICINA VO (14 DÍAS COMPLETADOS EL 20/04) POR 3 A 5 DÍAS MÁS AGREGANDO METRONIDAZOL EV. PACIENTE EVOLUCIONA ESTABLE HASTA EL 25/04/22, DONDE PRESENTA FIEBRE, COMPROMISO HEMODINÁMICO Y CLÍNICA DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL CON RESPUESTA PARCIAL A NBZ, POR LO QUE SE DECIDE CAMBIAR PREDNISONA VO POR HIDROCORTISONA EV, PANCULTIVAR Y ESCALAR TTO ATB A LINEZOLID EV + IMIPENEM EV (MANTENIENDO METRONIDAZOL EV).

PACIENTE EVOLUCIONA CON MALA RESPUESTA, HEMODINÁMICAMENTE INESTABLE CON NE HASTA 0.1 MCG/KG/MIN, FA CON RVR HASTA 170 Y FALLA VENTILATORIA. SE INDICA MANEJO CON BIC AMIODARONA Y RECIBE CON 5 L DE CRISTALOIDES. PRESENTA ADEMÁS TAQUIPNEA Y MALA MECÁNICA CON RX TÓRAX DE CONTROL DE CVC QUE EVIDENCIÓ COMPROMISO PARENQUIMATOSO CASI COMPLETO DEL PULMÓN DERECHO (ATELECTASIA VS NEUMONÍA EXTENSA), MALA RESPUESTA A VMNI Y BD POR CLÍNICA OBSTRUCTIVA, POR LO QUE SE DECIDE IOT. SE TRASLADA A UPC PARA CONTINUAR MANEJO.

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, CON MEJOR ESTABILIDAD CLÍNICA, POR EL MOMENTO MENOR REQUERIMIENTO DE DVA, NO IMPRESIONA SEPTICO, CON PARAMETROS INFLAMATORIOS A LA BAJA CON PCR: 21-->19, LEUCOS: 22-->25, AFEBRIL, CON LEISIONES MACULARES QUE AUN SE MANTIENEN GENERALIZADAS, AHORA CON MAYOR ZONAS DESCAMATIVAS PERO ALGUNA CON FRIABILIDAD DE SU EPIDERMIS, SE LOGRA RESCATAR REPORTE DEFINITIVOS DE CULTIVOS NEGATIVOS POR LO QUE SE CONSIDERA QUE SU PROCESO INFECCIOSO YA FUE TRATADO Y QUE NO GENERA UN ROL IMPORTANTE EN SU ESTADO Y PUDIERA SER ATRIBUIBLE A RAM, POR EL MOMENTO SE MANTIENE CON CORTICOIDES Y SEGUIMIENTO ESTRICTO CON DERMATOLOGÍA (A LA ESPERA DE BIOPSIA).

SE SUSPENDE TODO TTO ANTIBIOTICO, CON LO QUE HAY EVIDENTE MEJORA DE LESIONES DERMICAS. SE MANTIENE CON HIDRATACION FULL CON CREMA Y DEPLECION DE VOLUMEN

BAJO SEGUIMIENTO ESTRICTO DE DERMATOLOGIA. EVOLUCIONA CON REGRESION LENTA PERO PROGRESIVA DE RUSH CUTANEO

CAET (01/05) CON PRESENCIA DE PSAE MS + E. COLI BLEE (S: AMIKA, ERTA, IMI, MERO /R: CIPRO) + UC (03/05): PSAE (S: AMIKA, CEFTA, CIPRO, TAZO /R: IMI, MERO), POR LO QUE SE INICIÓ AMIKACINA EV A PSAE EN FOCO URINARIO. CONVERSADO CON INFECTOLOGIA, SE INICIA CIPROFLOXACINO + AMIKACINA NBZ. PARAMETROS INFLAMATORIOS A LA BAJA CON GB 11.290 / PCR 14. CARBAPENEMICO POR ALTO RIESGO DE RAM

EN CONTEXTO DE VMI PROLONGADA, SE CONVERSA CON FAMILIARES Y SE DECIDE REALIZAR TQT QUIRURGICA, PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZA EL 11/05

QUEDA EN EVIDENCIA MOVIMIENTOS ESTEREOTIPADOS PERIBUCALES, REPETITIVOS, POR LO QUE SE AVISA A

Fecha Última Actualización: 18-06-2022 3:13:14

Página 3 de 4

NEUROLOGO, QUIEN SOLICITA EEG CONTROL, QUE CONCLUYE ACTIVIDAD EPILEPTIFORME OCASIONAL. SE INICIA LEVETIRAZETAM CON BUENA RESPUESTA SIN CONFLICTO VENTILATORIO. SE LOGRA AVANZAR LENTAMENTE EN WEANING, MAS QUE NADA POR MIOPATIA DE PACIENTE CRITICO.

EN LA ULTIMA SEMANA, PRESENTA DETERIORO CLINICO PROGRESIVO, CON REQUERIMIENTOS DE DVA EN ASCENSO, ASI COMO RETROCESO EN LO VENTILATORIO Y ELEVACION DE LOS PARAMETROS INFLAMATORIOS. SE PANCULTIVA Y SE INICIA ESQUEMA ATB DE TERCERA LINEA ¿ DE LO QUE SE RESCATA PAE MS + CANDIDA EN UROCULTIVO, POR LO QUE SE CAMBIAN LOS DISPOSITIVOS.

SE AJUSTA TTO ATB A TAZONAM, CON LO QUE SE MANTIENE HASTA EL DIA DE HOY.

PRESENTA DETERIORO PROGRESIVO CON COMPROMISO DE CONCIENCIA SEVERO, SIN SEDACION, SIN RECUPERACION DE CONCIENCIA, ASI COMO FALLA ORGANICA.

SE MANTIENEN MEDIDAS DE SOPORTE, PESE A LO QUE EVOLUCIONA CON ALZA CONSTANTE DE DVA Y REQUERIMIENTOS DE O2. ¿ SE INFORMA A FAMILIARES DE PRONOSTICO OMINOSO Y EVENTUAL DESENLAZ FATAL.

SE CONSTATA FALLECIMIENTO DEL PACIENTE CITADO A LAS 02:45 DEL 18.06.2022

INTENTO CONTACTO TELEFONICO CON FAMILIAR ¿ HIJO TUTOR ¿ SIN ÉXITO. NO CONTESTA AL LLAMADO TELEFONICO

Diagnóstico de Egreso

Enterocolitis Debida A Clostridium Difficile -
Fibrilación Auricular Crónica -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en buenas condiciones generales, con HDN estable, afebril, sin requerimientos de O2. Con FC estables peri 100 lpm. Diarrea en disminución. Sin dolor abdominal, con buena tolerancia oral.

Plan Post Alta

Reposo relativo asistido, activar por kinesiología
Régimen liviano 200 gr H de C, bajo en Na, sin residuos

Medicamentos

Vancomicina 125 mg cada 6 horas VO hasta el 16/04/22 incluido.

B. Ipratropio 2 puff cada 6 horas con AEC (intercalar)

Berodual 2 puff cada 6 horas con AEC (intercalar)

Brexotide 2 puff cada 12 horas con AEC

Bisoprolol 2.5 mg al día VO

Atorvastatina 20 mg al día VO

Metformina 850 mg c/12 hrs VO

Losartan 25 mg c/12 hrs VO

Acenocumarol

Controles:

- Acudir a control con cardiología para seguimiento de FA agendar ecocardiograma para continuar estudio.

Consultar en urgencias en caso de dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor abdominal intenso, fiebre, mal estado general, perdida de conciencia o en caso que lo considere necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Hiposódico

Medicamentos :

Fecha Epicrisis : 18/06/2022 03:13

Página 3 de 4



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 18-06-2022 3:13:14

Página 4 de 4

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Eduardo Cisternas Fuentes
Médico Tratante (Staff)